

Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC
SitRep N°121/MVEBDB/12/09/2026

FAITS SAILLANTS (dernières 24h)



- Évolution légèrement favorable à consolider : 87 nouveaux cas contre 91 la veille (-4,4 %), mais légèrement au-dessus du 5 septembre (82 cas ; +6,1 %).
- Légère baisse des décès : 38 contre 39 la veille (-2,6 %), dont 28 communautaires et 10 intra-CTE.
- Aucune nouvelle zone de santé touchée, traduisant une stabilisation de l'extension géographique à consolider.
- La transmission reste concentrée en Ituri et au Nord-Kivu (81/87 ; 93,1 %), tandis que la forte proportion de décès communautaires (28/38 ; 73,7 %) demeure un point majeur de vigilance.

CUMUL DES CAS  7 200	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS  3 475	LETALITÉ  48,3%	PATIENTS EN ISOLEMENT/CTE  923	CUMUL DES GUÉRIS  1 712	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)  88,0 %
--	--	---	--	---	--



Provinces touchées et Zones de santé touchées



5 provinces actuellement affectées
Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo et Bas-Uélé



53 zones de santé actuellement affectées sur 117 (45,3 %)

Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au terme de la journée du **12 septembre 2026**, une **évolution légèrement favorable à consolider** est observée, avec **87 nouveaux cas confirmés**, contre **91 la veille (-4,4 %)**. Ce niveau demeure toutefois légèrement supérieur à celui observé le **5 septembre (82 cas ; +6,1 %)**. Les nouveaux cas ont été rapportés en **Ituri (44 cas)**, au **Nord-Kivu (37)**, au **Haut-Uélé (3)** et dans la **Tshopo (3)**, tandis qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré au **Bas-Uélé** ni au **Sud-Kivu**.

La mortalité enregistre également une **légère baisse par rapport à la veille**, avec **38 décès contre 39 (-2,6 %)**, dont **28 décès communautaires et 10 décès intra-CTE** (6 en Ituri et 4 au Nord-Kivu). Toutefois, les décès communautaires représentent encore **73,7 % (28/38)** des décès du jour et demeurent un point majeur de vigilance.

Par ailleurs, **20 patients ont été déclarés guéris** après deux résultats négatifs à la MVE, dont **13 en Ituri, 5 au Haut-Uélé et 2 au Nord-Kivu**.

Depuis le début de l'épidémie, la RDC cumule **7 200 cas confirmés et 3 475 décès**, soit une létalité de **48,3 %**. L'**Ituri demeure l'épicentre**, concentrant **78,0 % des cas confirmés cumulés et 50,6 % des nouveaux cas du jour**. L'Ituri et le Nord-Kivu concentrent ensemble **81/87 nouveaux cas (93,1 %)**, témoignant de la forte concentration actuelle de la transmission dans ces deux provinces.

Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée au cours des dernières 24 heures. Après exclusion des ZS n'ayant rapporté aucun cas confirmé depuis **plus de 42 jours**, **53 ZS demeurent actuellement affectées dans cinq provinces** : Ituri, Nord-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo et Bas-Uélé. Huit ZS ont franchi ce seuil : Adja (47 jours), Kambala (58 jours) et Mahagi (44 jours) en Ituri ; Goma (110 jours) au Nord-Kivu ; Miti (105 jours) au Sud-Kivu ; Wanie-Rukula (43 jours), Tshopo (45 jours) et Lubunga (49 jours) dans la Tshopo.

La répartition actualisée des ZS actuellement affectées est ainsi de 25/36 en Ituri, 15/34 au Nord-Kivu, 6/13 au Haut-Uélé, 4/23 dans la Tshopo et 3/11 au Bas-Uélé. Le Sud-Kivu ne figure plus parmi les provinces actuellement affectées, son unique ZS touchée, Miti, ayant dépassé 42 jours sans nouveau cas confirmé. Le Sud-Ubangi demeure suivi séparément, le cas détecté dans la ZS de Bulu étant considéré comme importé, sans transmission locale établie à ce stade. Cette évolution traduit une stabilisation de l'extension géographique de l'épidémie à consolider, malgré la persistance d'une transmission active, principalement en Ituri et au Nord-Kivu, et le maintien d'une proportion élevée de décès communautaires.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée depuis le début de l'épidémie.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Total cas confirmés	Total décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	44	5615	2 559	45,6%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	37	1269	786	61,9%	16/34 (47,0 %)
Haut-Uélé	3	279	115	41,2%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	3	28	10	35,7%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	5	3	60,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	1	1	100,0%	1/16 (6,3%)
Total	87	7 200	3 475	48,3%	62/167 (37,1 %)

Tableau 2. Situation actuelle des zones de santé affectées après application du critère des 42 jours

Province	ZS ayant historiquement rapporté des cas	ZS >42 jours sans cas	ZS actuellement affectées
Ituri	28/36	3 (Adja, Kambala, Mahagi)	25/36
Nord-Kivu	16/34	1 (Goma)	15/34
Haut-Uélé	6/13	0	6/13
Tshopo	7/23	3 (Wanie-Rukula, Tshopo, Lubunga)	4/23
Bas-Uélé	3/11	0	3/11
Total	60/117	7	53/117 (45,3 %)

Depuis le début de l'épidémie, la RDC cumule 7 200 cas confirmés et 3 475 décès (létalité : 48,3 %). Toutefois, l'application du critère de plus de 42 jours sans nouveau cas confirmé permet de mieux distinguer la situation historique de la transmission actuellement active. Ainsi, 53 ZS sur les 117 ZS des cinq provinces actuellement affectées (45,3 %) demeurent concernées. Le Sud-Kivu ne figure plus parmi les provinces actuellement affectées, tandis que le Sud-Ubangi demeure suivi séparément en raison du cas importé détecté à Bulu, sans transmission locale établie à ce stade.

Tableau 3. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 12 septembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	5615	2559	45,6%	44	20	6	26
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	179	39	21,8%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1564	495	31,6%	14	8		8
Damas	39	9	23,1%	3	0		0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	78	30	38,5%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	33	12	36,4%				0
Komanda	132	88	66,7%	5	4		4
Lita	259	127	49,0%	3	2		2
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	31	8	25,8%				0

Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	47	25	53,2%	1	1		1
Mangala	312	146	46,8%	2	0		0
Mongbwalu	658	298	45,3%	4	2		2
Nia-Nia	237	120	50,6%	5	3		3
Nizi	729	273	37,4%				0
Nyankunde	125	36	28,8%				0
Rimba	11	4	36,4%				0
Rwampara	1013	349	34,5%	6	0		0
Tchomia	69	25	36,2%	1	0		0
A ventiler *	NA	436	NA			6	6
Nord-Kivu	1269	786	61,9%	37	8	4	12
Beni	222	162	73,0%	14	5	1	6
Biena	16	7	43,8%	1	1		1
Butembo	236	152	64,4%	6	0		0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	30	12	40,0%	1	0		0
Katwa	523	332	63,5%	10	1	1	2
Kayna	1	0	0,0%				
Kyondo	29	18	62,1%				0
Lubero	15	7	46,7%				0
Mabalako	19	9	47,4%				0
Manguredjipa	8	3	37,5%				0
Masereka	20	8	40,0%	1	0		0
Musienene	115	62	53,9%	2	1	2	3
Mutwanga	6	2	33,3%	1	0		0
Oicha	11	7	63,6%				0
Vuhovi	17	5	29,4%	1	0		0
Haut-Uélé	279	115	41,2%	3	0	0	0
Boma Mangbetu	32	14	43,8%	3	0	0	0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	96	41	42,7%				0
Pawa	57	25	43,9%				0
Rungu	2	1	50,0%				0
Wamba	89	33	37,1%				0
Tshopo	28	10	35,7%	3	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%	2	0	0	0
Kabondo	4	1	25,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	10	5	50,0%				0
Mangobo	4	2	50,0%	1	0	0	0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0

Bas-Uélé	5	3	60,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,00%				0
Viadana	1	0	0,00%				0
Ganga	3	2	66,67%				0
Sud Ubangi	1	1	100,0%	0	0	0	0
Bulu	1	1	100,0%				0
Total	7200	3475	48,3%	87	28	10	38

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

La transmission demeure fortement concentrée en Ituri et au Nord-Kivu, qui totalisent 81/87 nouveaux cas (93,1 %), avec des foyers particulièrement actifs à Bunia, Beni, Katwa, Rwampara, Komanda, Nia-Nia et Mongbwalu. Les 38 décès du jour, dont 28 communautaires (73,7 %), soulignent la persistance d'une mortalité communautaire élevée. Le cumul national s'établit à 7 200 cas confirmés et 3 475 décès (48,3 %). L'absence de nouveau cas au Sud-Kivu constitue un acquis à consolider ; cette province sort de la catégorie des provinces actuellement affectées après plus de 42 jours sans cas, tandis que le Sud-Ubangi demeure suivi séparément en raison du cas importé de Bulu, sans transmission locale établie.

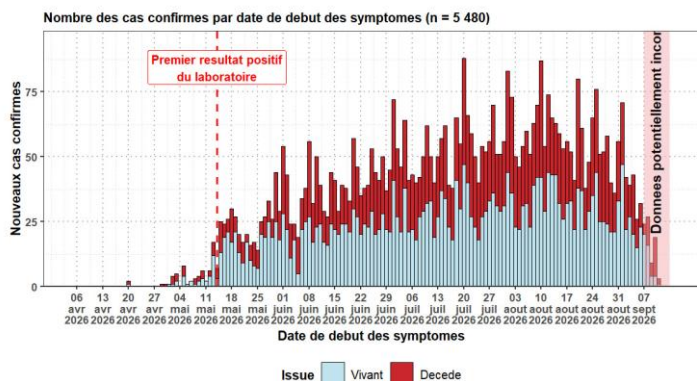
Tableau 4. Situation des alertes notifiées par province, au 12 septembre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	29	4	33	11	1	18	3	12	11
Bas-Uélé	31	0	31	6	0	25	0	6	3
Ituri	818	95	913	176	88	483	6	264	134
Nord-Kivu	869	59	928	95	59	764	0	154	43
Sud-Kivu	11	0	11	1	0	3	0	1	1
Sud Ubangi	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	60	2	62	6	2	54	0	8	5
Total Général	1 818	160	1 978	295	150	1 347	9	445	197

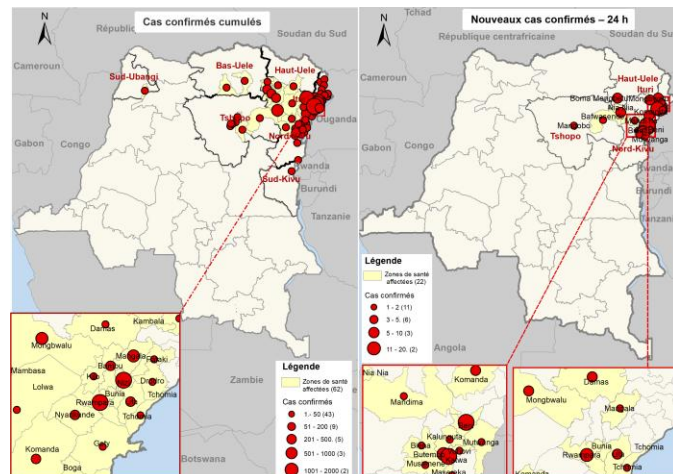
La surveillance maintient une bonne performance, avec environ 91,1 % (1 801/1 978) des alertes vérifiées et 100 % (445/445) des cas suspects investigués. L'Ituri et le Nord-Kivu concentrent 93,1 % des alertes reçues. Toutefois, la faible proportion des suspects investigués transférés vers les CT/CTE (197/445 ; 44,3 %), particulièrement au Nord-Kivu (43/154 ; 27,9 %), constitue un point majeur d'attention. L'absence de données du Sud-Ubangi nécessite également une correction rapide afin de garantir le suivi autour du cas importé.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumulés) par zone de santé.



Source : DHIS2 Tracker - Riposte MVE, septembre 2026. Données incluses : cas confirmés avec statut vital et date de début de symptômes renseignés, n = 5 480.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- **Visite du Professeur Jean-Jacques Muyembe à la Coordination de la riposte MVE-17 à Bunia**, suivie d'une réunion d'échanges avec les principaux acteurs impliqués dans la riposte, consacrée à l'analyse de la situation épidémiologique, aux défis opérationnels, au partage des expériences de terrain ainsi qu'aux orientations scientifiques et techniques pour renforcer les interventions ;
- Poursuite des **réunions de coordination et d'analyse de la situation épidémiologique**, avec revue des performances des différents piliers, identification des gaps prioritaires et formulation d'actions correctrices ;
- Renforcement du **suivi différencié des provinces et des foyers actifs**, avec une attention particulière à l'Ituri et au Nord-Kivu où demeure concentrée l'essentiel de la transmission, ainsi qu'aux provinces enregistrant une accalmie ;
- Poursuite du **suivi de la situation au Sud-Ubangi autour du cas importé de Bulu**, afin de prévenir l'établissement d'une transmission locale ;
- Poursuite de la **coordination avec les DPS, les piliers techniques et les partenaires** pour le suivi des gaps opérationnels et la mobilisation des appuis nécessaires ;
- Renforcement du **suivi de la qualité et de la cohérence des données de la riposte**, notamment pour améliorer leur consolidation, leur analyse et leur utilisation dans la prise de décision.

1.2. Défi majeur

Adapter en permanence la coordination et l'allocation des ressources à l'évolution différenciée de l'épidémie, en intensifiant les interventions dans les foyers à transmission active tout en consolidant les acquis dans les zones en accalmie et en prévenant l'apparition de nouveaux foyers.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1.1. Surveillance épidémiologique

2.1.2. Principales Actions

Parmi les 7 provinces affectées, 6 d'entre-elles ont enregistré un total de **1 978 alertes** pour la journée du 12 septembre 2026, dont 1 801 (91,1%) ont été vérifiées. Ainsi, **445 alertes ont été validées comme cas suspects**. Ces derniers ont tous été investigués (100 %), dont **197 ont été transférés vers les CT/CTE** ([Tableau 3](#)).

S'agissant de la proportion du suivi des contacts, elle se situe à 88,0% (24 476/27 816), supérieure à la fois au jour précédent (87,5%) et au seuil de 85 % ; 88,7% en Ituri (13 230/14 920), 87,6% au Nord-Kivu (10 780/12 310), 83,4% au Bas-Uélé (151/181), 82,0 % à la Tshopo (209/255) et 70,7% au Haut-Uélé (106/150).

2.1.3. Défis

Suivi des contacts sous-optimal dans 3 provinces sur les 5 ayant des contacts en cours de suivi avec un recul important dans la province du Haut-Uélé, causé par une faible complétude.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Six (6) alertes ont été notifiées aux différents PoE/PoC pour la journée du 12 septembre, dont cinq (5) en Ituri et une (1) au Haut-Uélé ; toutes concernaient des corps sans vie et aucune alerte vivante n'a été validée. En Ituri, trois corps ont été interceptés au PoC de Kasenyi (ZS de Tchomia) et deux dans la ZS de Mahagi (PoC d'Anzida et Barrière DGDA) ; deux d'entre eux ont été swabés avec des résultats négatifs, les trois autres étant passés sans document de swab, soit une proportion de corps sans vie swabés/sécurisés de 40 % (2/5). Au Haut-Uélé, un corps sans vie a été intercepté au PoC de PK10 Route Poko (ZS d'Isiro), isolé, swabé et validé avec un résultat négatif (100 %).

Tableau 5. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 12 Septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Global
Complétude des rapports	96,7% (58/60)	100% (19/19)	55,5% (5/9)	100% (18/18)	54,5% (6/11)	90,6% (106/117)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	135 245	89 127	8 361	16 105	12 090	260 928
% des voyageurs screenés	98,00%	97,65%	98,80%	99,10%	98,00%	97,90%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,20%	97,65%	98,80%	98,80%	97,00%	97,40%
% des voyageurs sensibilisés	99,40%	97,65%	100,00%	100,00%	100,00%	98,90%
Nombre d'alertes notifiées	5	0	0	0	1	6
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	0	0	0	0	0	0
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	5	0	0	0	1	6
% des cas suspects transférés au CT/CTE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
% des corps sans vie swabés/sécurisés	40% (2/5)	NA	NA	NA	100% (1/1)	50% (3/6)
% des cas suspects investigués dans 24 h	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2.2.2. Défis

Malgré la fonctionnalité de l'ensemble des PoE/PoC stratégiques et des performances élevées de screening des voyageurs, **la sécurisation des corps sans vie interceptés demeure insuffisante**, avec seulement **3/6 corps swabés/sécurisés (50 %)**, principalement en raison de la faible performance observée en Ituri (**2/5 ; 40 %**). À cela s'ajoute la **faible complétude des rapports au Haut-Uélé (54,5 %)**, susceptible de limiter le suivi exhaustif des activités aux points d'entrée et de contrôle.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 44 nouveaux résultats positifs** (24 vivants et 20 décès) sur 248 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 17,7%**) ;
- **Nord-Kivu : 37 nouveaux résultats positifs** (29 vivants et 8 décès) sur 157 échantillons analysés (**positivité de 23,5%**) ;
- **Haut-Uélé : 3 nouveaux résultats positifs** (3 vivants) sur 25 échantillons analysés (**positivité : 12%**) ;
- **Tshopo : 3 échantillons reçus et testés** (2 vivants et 1 décès) **tous se sont révélés positifs** ;
- **Bas-Uélé : 3 échantillons reçus et testés** (2 vivants et 1 décès), **tous se sont révélés négatifs**.

2.3.2. Défi majeur

La **persistance d'une positivité élevée des échantillons**, particulièrement au Nord-Kivu (**23,5 %**) et en Ituri (**17,7 %**), témoigne du maintien d'une transmission active. La proportion importante de résultats positifs issus de prélèvements sur des personnes décédées, notamment en Ituri (**20/44 positifs ; 45,5 %**), demeure également préoccupante et souligne la nécessité de renforcer la **détection précoce des cas, le prélèvement rapide des suspects vivants et leur orientation vers les structures de prise en charge avant le décès**.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 28 rings ont été ouverts sur les 66 attendus (42,4 %), 147 ménages décontaminés sur 220 identifiés (66,8 %) et 7 FOSA décontaminées sur 9 (77,7 %) ; 60 kits PCI ont été dotés aux ménages à Mongbwalu. Quant aux EDS, 92 alertes ont été enregistrées, 74 EDS réalisés (80,4 %) et 63 corps swabés, 9 échecs enregistrés à Fataki et Mandima notamment ;
- **Au Nord-Kivu**, 31 rings ont été ouverts sur les 48 attendus (64,6 %), 10 ménages décontaminés sur 66 identifiés (15,2 %) et 24 FOSA décontaminées sur 36 (66,7 %) ; promptitude et complétude de 62,5 % (10/16 ZS touchées). Quant aux EDS, 61 alertes ont été reçues (dont 21 reports de la veille), 56 EDS réalisés et 59 corps swabés, 2 échecs à Kalunguta et Vuhovi ;
- **À la Tshopo**, évaluation PCI du nouveau CTE Météo avec un score de 90,3 % ; suivi et accompagnement de 15 ESS, briefing de 148 prestataires de première ligne dans 5 zones de santé, 12 DLM suivis, 10 unités de triage installées et 500 litres d'eau approvisionnés à Lubunga ; autour des derniers cas confirmés, 1 ring ouvert à Bafwasende avec décontamination d'une FOSA et de 6 ménages et dotation d'un kit PCI/EHA. Quant aux EDS, 3 alertes ont été enregistrées et 3 corps swabés (100 %) pour 2 EDS réalisés ;
- **Au Bas-Uélé**, 1 ring a été ouvert sur 1 attendu (100 %) à Ganga, sans ménage ni FOSA décontaminés (0/1 pour chacun), la décontamination du ménage du cas confirmé du 11 septembre et de l'HGR de Ganga étant en cours ; briefing de 33 prestataires de soins et de 13 hygiénistes dans 15 ESS de 3 zones de santé ;
- **Au Haut-Uélé**, 5 rings ont été ouverts sur les 6 attendus (83 %), 5 ménages décontaminés sur 6 identifiés (83 %) et 1 FOSA décontaminée sur 1 (100 %), portant les cumuls à 16/16 ménages et 8/8 FOSA. Quant aux EDS, 2 alertes ont été enregistrées et 2 EDS réalisés avec swab (100 %).

2.4.2. Défis

Malgré les progrès observés dans certaines provinces, la **couverture encore insuffisante des rings PCI et des décontaminations autour des cas confirmés** demeure préoccupante, particulièrement en Ituri avec seulement **28/66 rings ouverts (42,4 %)** et au Nord-Kivu avec **10/66 ménages décontaminés (15,2 %)**. À cela s'ajoutent les **échecs d'EDS**, notamment en Ituri, ainsi que la nécessité d'assurer rapidement la décontamination des ménages et FOSA exposés afin de **réduire le risque de transmission nosocomiale et communautaire**.

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 131 nouvelles admissions dans les différentes structures dédiées contre 88 sorties dont 13 guéries. Ainsi, 476 patients sont hospitalisés pour 1015 lits, soit un taux d'occupation de 46,9% ; 435/463 (94 %) patients ont bénéficié de repas chaud ; 11/11 (100 %) enfants sont sous LNPE/SLM au CTE, 5/5 (100 %) à la crèche et 28/28 (100 %) dans la communauté ;
- **Au Nord-Kivu**, 82 nouvelles admissions contre 60 sorties enregistrées dont 2 guéries ; 342 patients sont hospitalisés, soit un taux d'occupation global en sursaturation (150,0%), sans aucun lit disponible dans les CTE/CT de Butembo et Katwa ; 64/64 malades (100 %), 8/8 accompagnants et 52/52 prestataires de première ligne ont bénéficié de repas chauds ;
- **Au Haut-Uélé**, 11 nouvelles admissions contre 9 sorties (5 guéries). Ainsi, 69 patients sont hospitalisés pour 134 lits, soit un taux d'occupation de 51,5% ; 42 patients, 55 accompagnants et 26 PPL ont bénéficié de repas chauds, à l'exception des CTE de Boma Mangbetu, Rungu et Gombari ; début du traitement prophylactique et spécifique au CTE d'Isiro par l'équipe de l'INRB ;
- **Au Bas-Uélé**, 3 nouvelles admissions contre 2 sorties (1 non-cas et 1 évadé) ; 7 patients demeurent en isolement dont 1 cas confirmé pris en charge à l'HGR de Ganga, 11 contacts à haut risque sont sous prophylaxie à Buta et à Ganga, pour une complétude des données de prise en charge de 38 % (5/13) ;

- **À la Tshopo**, 9 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 3 sorties. Douze (12) patients sont en isolement pour 31 lits, soit un taux d'occupation de 38,7% ;
- **Au Sud-Kivu**, une (1) nouvelle admission a été enregistrée, aucune sortie signalée. Dix-sept (17) patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation de 68,0%.

2.5.2. Défis

La **sursaturation persistante des capacités de prise en charge au Nord-Kivu**, avec un taux d'occupation global de **150,0 %** et **aucun lit disponible dans les CT/CTE de Butembo et Katwa**, constitue le principal défi et expose à des difficultés d'admission, d'isolement et de prise en charge rapide des nouveaux cas. À cela s'ajoutent la **faible complétude des données de prise en charge au Bas-Uélé (5/13 ; 38 %)** et la nécessité de garantir la continuité de l'appui nutritionnel dans l'ensemble des CTE, notamment au Haut-Uélé.

2.6. Vaccination et prophylaxie post-exposition

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, fin de la formation des vaccinateurs et des sensibilisateurs dans le cadre des préparatifs de la vaccination des PPL, dont le démarrage est prévu le 15 septembre 2026 à Bunia ;
- **À la Tshopo**, 119 cas ont reçu le traitement expérimental, dont 14 confirmés et 105 sous prophylaxie post-exposition (68 traitements terminés, 11 interrompus et 26 en cours) ; transfert de 3 contacts à haut risque du CTE vers le centre de transit de l'HGR Makiso-Kisangani et briefing des acteurs CREC sur le fonctionnement du CTE/CT. Au Haut-Uélé, briefing des prestataires sur l'utilisation du traitement spécifique et prophylactique de la MVE et obtention, avec l'équipe de l'INRB, du consentement éclairé des patients positifs en vue de l'adjonction d'une nouvelle molécule.

2.6.2. Défis

Assurer le **démarrage effectif et la montée en charge de la vaccination des prestataires de première ligne en Ituri**, prévue à partir du 15 septembre 2026, tout en renforçant le **suivi systématique de la prophylaxie post-exposition (PEP)**, notamment la documentation des personnes exposées évaluées, éligibles, mises sous prophylaxie, ayant terminé ou interrompu le traitement. Une attention particulière doit être accordée aux **interruptions de traitement observées à la Tshopo (11/105 bénéficiaires de la PEP)** afin d'en identifier les causes et d'améliorer l'adhésion au protocole.

2.7. Communication sur les risques et engagement communautaire

2.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 14 833 visites à domicile ont touché 50 031 personnes et 746 causeries éducatives ont permis d'atteindre 13 640 personnes ; 46 actions de sensibilisation de masse ont touché 6 553 personnes, 2 débats communautaires 66 personnes et 7 plaidoyers 29 personnes ; 172 alertes communautaires ont été notifiées (dont 20 décès), 7 des 18 feedbacks résolus dans les 48 heures et les 2 incidents communautaires enregistrés résolus à Nizi et Nia-Nia ; en appui aux piliers, prélistage de 181 contacts autour de 13 cas confirmés, facilitation de la décontamination de 46 ménages et d'une structure de soins, 10/15 EDS (67 %) et annonce de 14 résultats positifs ;
- **Au Nord-Kivu**, 41 093 personnes touchées au cours de 17 000 visites à domicile, 2 341 personnes atteintes lors de 68 causeries éducatives, 3 996 lors de 23 actions de communication de masse et 88 lors de 2 briefings ; 174 alertes communautaires notifiées sur 450 attendues (38,6 %), 7 feedbacks résolus sur 13 (53,8 %), 1 186 personnes engagées sur 4 750 (24,9 %) et 3 incidents communautaires résolus (33,3 %) ;
- **Au Bas-Uélé**, 2 469 personnes ont été sensibilisées en milieu scolaire (909 hommes et 1 560 femmes) ; briefing et plaidoyer auprès de 19 prêtres du diocèse de Buta, sensibilisation de 10 membres du COGE de la zone de santé de Ganga et appui au briefing de 39 prestataires de soins de Buta ;

- **À la Tshopo**, 388 ménages visités ont touché 2 139 personnes, 2 causeries éducatives 44 personnes à Isangi et les actions de sensibilisation de masse 1 871 personnes dans les 5 zones de santé de Kisangani et 6 établissements scolaires ; 8 spots diffusés dans 4 organes de presse ; 13 alertes communautaires notifiées et toutes résolues, ainsi que 3 feedbacks et 1 incident communautaire résolu dans les 48 heures ;
- **Au Haut-Uélé**, 43 causeries éducatives ont touché 587 personnes et 254 visites à domicile 1 285 personnes dans les ZS de Wamba et de Pawa ; 4 actions de masse ont atteint 411 personnes au CTE de Wamba et 1 dialogue communautaire 61 personnes à Isiro, tandis que le dialogue mené autour des derniers cas confirmés a touché 59 personnes ; 15 alertes de cas suspects et de décès notifiées par les acteurs communautaires, 18 feedbacks résolu dans les 48 heures, 2 344 personnes engagées et 1 incident de résistance résolu à Isiro ; la préparation conjointe du déchargement de 17 vainqueurs se poursuit à Pawa, Wamba et Gombari.

2.7.2. Défis

Malgré l'intensification des activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire, **la faible remontée des alertes communautaires, la résolution encore insuffisante des feedbacks et la faible mobilisation des acteurs communautaires au Nord-Kivu** demeurent préoccupantes, avec seulement **174/450 alertes attendues notifiées (38,6 %)**, **7/13 feedbacks résolus (53,8 %) et 1 186/4 750 personnes engagées (24,9 %)**. En Ituri, la faible résolution des feedbacks dans les 48 heures (**7/18 ; 38,9 %**) constitue également un gap nécessitant le renforcement des mécanismes d'écoute, de rétro-information et d'engagement communautaire.

2.8. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 15 personnes parmi les nouveaux cas confirmés et 103 des 151 cas confirmés en cours de suivi (68 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 40 des 116 nouveaux suspects (34 %) et 104 des 137 suspects en cours de suivi (76 %) ; 56 annonces de résultats réalisées dont 15 positifs, 67 PPL soutenus et 39 ménages accompagnés, 25 enfants suivis, 6/6 enfants suivis en crèche et 12 des 16 guéris (75 %) suivis dans la communauté ;
- **À la Tshopo**, 1 nouveau cas confirmé, 2 cas confirmés en cours de suivi, 3 nouveaux cas suspects et 6 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 5 annonces de résultats réalisées dont 1 positif ; 13 accompagnants au CTE, 5 PPL et 25 contacts soutenus à l'HGR Makiso-Kisangani, préparation psychologique de l'équipe EDS et 2 guéris ayant intégré les équipes de riposte ;
- **Au Haut-Uélé**, 6 nouveaux cas confirmés et 24 cas confirmés en cours de suivi, 5 nouveaux cas suspects et 8 suspects en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS, ainsi que 70 accompagnants au CTE et 35 PPL ; 28 résultats de laboratoire ont été annoncés dont 10 positifs ; 4 guéris (3 à Isiro et 1 à Wamba) sont sortis sans kit de déchargement.

2.8.2. Défis

La **couverture encore insuffisante des interventions de santé mentale et de soutien psychosocial auprès de certaines catégories prioritaires**, particulièrement en Ituri où seulement **40/116 nouveaux cas suspects (34 %) et 103/151 cas confirmés en cours de suivi (68 %) ont bénéficié d'un accompagnement SMSPS**, demeure un gap important. À cela s'ajoute au Haut-Uélé la **sortie de 4 guéris sans kit de déchargement**, nécessitant de renforcer la continuité de l'accompagnement psychosocial, depuis l'admission jusqu'à la réintégration communautaire des personnes guéries.

2.9. Logistique

2.9.1. Principales actions

- **En Ituri**, 26 patients ont été évacués et 17 des 33 transferts organisés ont été réalisés (51,5 %). Au Nord-Kivu, 19 appels ont été reçus pour 16 courses réalisées et 16 réussies (96 %)

et 9 ambulances mobilisées sur les 11 disponibles (82 %), 3 appels n'ayant pu être honorés du fait de la saturation des lits à Katwa ;

- **À la Tshopo**, 2 appels ont été reçus pour 2 courses réalisées et toutes réussies (100 %), avec 3 ambulances utilisées sur les 3 disponibles ; suivi de la construction du CTE de Bafwasende et de l'isolement de Madula, poursuite des démarches foncières pour l'HGR Makiso-Kisangani, appui à la mobilité des piliers et mise à disposition d'intrants PCI ;
- **Au Bas-Uélé**, aucune donnée logistique n'a été transmise au cours des dernières 24 heures.

2.9.2. Défi majeur

La **capacité encore insuffisante à assurer l'ensemble des transferts et évacuations des patients**, particulièrement en Ituri où seulement **17/33 transferts organisés ont été réalisés (51,5 %)**, demeure un gap important. Au Nord-Kivu, la **saturation des capacités d'hospitalisation à Katwa a empêché la prise en charge de 3 appels**, montrant l'interdépendance entre disponibilité des lits et performance logistique

2.10. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.10.1. Principales actions.

- **En Ituri**, 12 membres du personnel de la riposte (7 hommes et 5 femmes) ont reçu le briefing PSEA ; 385 personnes (236 hommes et 149 femmes) ont été sensibilisées dans la communauté et deux partenaires (OMS et Mercy Corps) ont rapporté leurs activités PSEA. Au Bas-Uélé, consultation communautaire de 65 participants à Koteli et mise en place d'un comité de gestion des plaintes de 11 membres dont 9 femmes

2.10.2. Défis

La **couverture encore limitée des activités de PSEA au sein de la riposte**, tant auprès du personnel que des communautés, ainsi que la **faible remontée des activités par les partenaires**, dont seulement deux ont rapporté leurs interventions en Ituri, demeurent des points d'attention. Il est nécessaire de renforcer le **briefing systématique du personnel de la riposte, la sensibilisation communautaire, la mise en place de mécanismes accessibles et confidentiels de gestion des plaintes et le rapportage régulier des activités PSEA par l'ensemble des partenaires.**

2.11. Base des données

2.11.1. Principales actions

- Poursuite de la **centralisation, consolidation et mise à jour des données épidémiologiques** provenant des provinces affectées et des différents piliers de la riposte, en vue de leur utilisation dans le SitRep et les outils de suivi de la Coordination ;
- Poursuite du **contrôle de la qualité des données**, notamment la recherche des doublons, des données manquantes et des incohérences entre les différentes sources d'information : surveillance, laboratoire, prise en charge, listes linéaires et DHIS2 ;
- Renforcement de la **confrontation et de la concordance des bases de données**, particulièrement pour les cas confirmés, les décès, les guéris et leur ventilation par province et zone de santé, afin de disposer de chiffres harmonisés pour la prise de décision ;
- Préparation de la **formation des cadres de la DPS Ituri et des zones de santé ciblées sur la saisie, l'analyse et la visualisation des données à l'aide de DHIS2 Capture**, prévue du **14 au 16 septembre 2026**, afin de renforcer les capacités décentralisées de gestion et d'utilisation des données ;
- Poursuite des échanges avec les provinces et les piliers pour améliorer la **complétude, la promptitude et la cohérence du rapportage**, ainsi que la correction des anomalies identifiées avant la consolidation des données au niveau national.

2.11.2. Défi majeur

La persistance d'**incohérences, de données manquantes et de discordances entre les différentes sources et bases de données de la riposte** demeure un défi pour la production en temps opportun d'une information épidémiologique unique, fiable et validée. Le renforcement du **contrôle qualité, de la déduplication, de la concordance entre les bases et des**

MESSAGES CLES

- **Les performances de la surveillance se maintiennent à un niveau satisfaisant, avec 100 % des cas suspects investigués** et une légère progression du suivi des contacts à **88,0 % (24 476/27 816), contre 87,5 % la veille**, restant au-dessus du seuil de performance de 85 %.
- **L'absence de nouvelle zone de santé touchée constitue un signal favorable de stabilisation de l'extension géographique à consolider.** La transmission demeure toutefois soutenue en **Ituri, au Nord-Kivu et au Haut-Uélé**, tandis que la **Tshopo et le Bas-Uélé** présentent une transmission plus sporadique. Le Sud-Kivu est en accalmie avancée, tandis que le Sud-Ubangi demeure sous surveillance renforcée autour du **cas importé de Bulu**, sans transmission locale établie à ce stade.
- Au cours des dernières 24 heures, **87 nouveaux cas confirmés** ont été rapportés. Par ailleurs, **38 décès ont été enregistrés, dont 28 communautaires et 10 intra-CTE**, portant le cumul national à **7 200 cas confirmés et 3 475 décès**, soit une létalité de **48,3 %**. La proportion élevée des décès communautaires (**28/38 ; 73,7 %**) demeure un point majeur de vigilance.
- **L'Ituri demeure le principal foyer en termes de charge cumulée, avec 5 615 cas, soit 78,0 % du cumul national, et concentre 44/87 nouveaux cas (50,6 %).** Avec le Nord-Kivu, les deux provinces totalisent **81/87 nouveaux cas (93,1 %)**, justifiant une intensification ciblée des interventions dans les foyers actifs.
- Les priorités immédiates demeurent le renforcement de la détection précoce et du transfert des cas suspects, la réduction des décès communautaires, l'intensification de la PCI et de l'engagement communautaire, ainsi que l'augmentation urgente des capacités d'accueil des CT/CTE au Nord-Kivu, où la prise en charge demeure en sursaturation.
- Enfin, il convient de consolider les acquis dans les zones en accalmie et de renforcer la préparation et la réponse dans les provinces du corridor fluvial et les autres zones à risque, afin de prévenir l'apparition et l'installation de nouveaux foyers.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve
E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard
Dr KATUSI BISELENGE Jules
Madame MAYELE AFUA Marie
Dr DIUR MANANASHI Floryan
Mr KAMWINA KEBELA John



Contact :
www.sante.gouv.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.